

1 実践チェックリスト(保険薬局/病院)

保険薬局薬剤師

- 1 カペシタビン・FTD/TPI・レゴラフェニブの服用日と残薬の管理
- 2 ワルファリン等の併用薬、市販の下痢止め・サブリの確認
- 3 電話フォローで下痢・発熱・ポンプ抜針後の状況を確認
- 4 手足症候群・皮疹のスキンケア指導と外用薬の使い方
- 5 症状をGradeで記録し、トレーシングレポートで病院へ

病院と共有する情報

バイオマーカー・レジメン
(お薬手帳)

検査値

(好中球数・Mg・尿蛋白)

下痢・手足症候群のGrade
(トレーシングレポート)

服用状況・家庭血圧
(電話フォローの結果)

病院薬剤師

- 1 RAS/BRAF/MSI・UGT1A1の結果とレジメンの整合性の監査
- 2 オキサリプラチン・イリノテカンの投与量と前投薬の確認
- 3 携帯型ポンプ(5-FU持続静注)の準備と使い方の説明
- 4 周術期の抗VEGF薬の休薬期間の管理
- 5 お薬手帳へのレジメン情報・投与日の記載

2 主なレジメンと薬局での確認ポイント

mFOLFOX6 点滴・注射	オキサリプラチン+レボホリナート+5-FU急速静注 → 5-FU 46時間持続静注	2週毎	✓ 携帯型ポンプの管理・抜針日 ✓ 寒冷刺激による急性しびれ
CAPOX 点滴+経口	オキサリプラチン(1日目)+カペシタビン 1日2回 1~14日目内服	3週毎	✓ 内服日数と休薬期間 ✓ 手足症候群 ✓ ワルファリン併用時のINR
FOLFIRI 点滴・注射	イリノテカン+レボホリナート+5-FU急速静注 → 46 時間持続静注	2週毎	✓ 遅発性下痢時の下痢止めの使い方 ✓ UGT1A1 ✓ 脱毛
FTD/TPI 点滴+経口	トリフルリジン・チピラシル 1日2回 1~5日目・ 8~12日目内服(土ベバシズマブ)	4週毎	✓ 食後服用(空腹時は吸収が増え好中球減少が増強) ✓ 骨髄抑制
レゴラフェニブ 経口	1日1回 1~21日目内服(低用量から漸増する方法も)	4週毎	✓ 低脂肪食後に服用 ✓ 手足症候群 ✓ 投与初期2か月の肝機能・血圧

● 経口 ● 点滴・注射 ● 点滴+経口 経口薬は保険薬局で交付:服用日・休薬日と自宅での副作用を確認

3 相互作用・併用注意(他院処方・市販薬・サブリを含む)

重要度	薬剤(機序)	相手の薬(区分)	起こること	薬局での対応
禁忌 添付文書 併用禁忌	S-1 DPD阻害(ギメラシル)	処方薬 他のフッ化ピリミジン系(カペシタビン・5-FU 等)	5-FU濃度↑ → 重篤な骨髄抑制・ 下痢	切り替え時は7日以上空ける
注意 添付文書 警告・併用注意	カペシタビン・S-1 CYP2C9の抑制	処方薬 ワルファリン・フェニトイン	INR↑(出血)・フェニトイン中毒	INR測定を頻度を処方医と確認
注意 添付文書 併用注意	レゴラフェニブ CYP3A4阻害・誘導	処方薬 クラリスロマイシン・アゾール系・リファンピ シン	副作用↑・効果↓	他院の抗菌薬・抗真菌薬の処方を確認
注意 添付文書 用法	レゴラフェニブ 食事で吸収が変化	生活習慣 空腹時・高脂肪食後の服用	効果減弱のおそれ	低脂肪の食事の後に服用するよう指導
注意 添付文書 用法	FTD/TPI 空腹時は吸収が増加	生活習慣 空腹時の服用	好中球減少が増強	朝・夕の食後に服用するよう指導
確認 服薬指導上の注 意	イリノテカン(遅発性下痢) 過量・症状を隠す	市販薬 市販の下痢止め	脱水・感染性腸炎の見逃し	下痢止めの使用量と回数、発熱の有無を確認

4 服薬指導の声かけ例と確認のタイミング

① 治療開始前	② 投与後~5日	③ 投与後1~2週	④ 次回来局時
“冷たい物に触れると、指先やのどがピリ ッとすることがあります。手袋や常温の 飲み物で予防しましょう	“水のような下痢が続く時は、お渡しした 下痢止めを指示どおりに。回数が1日4回 以上増えたら連絡を	“37.5℃以上の熱が出たら、解熱剤で様子 を見ずに、すぐ病院へ連絡してください	“手足の赤みや痛み、ボタンが留めにくい などの変化はありませんか
✓ 薬局で確認 お薬手帳でRAS/BRAF/MSI・UGT1A1、併用 薬(ワルファリン・フェニトイン)	✓ 薬局で確認 電話フォローで下痢の回数・水分量、携帯型 ポンプの抜針	✓ 薬局で確認 電話フォローでnadir期の発熱・口内炎、カ ペシタビンの服用日数	✓ 薬局で確認 手足症候群・しびれのGrade、家庭血圧・尿 蛋白、皮疹
△ ここに注意 ワルファリン併用中はINR測定の予定を確認	△ ここに注意 水様便が止まらない・発熱を伴う時は至急連 絡	△ ここに注意 発熱・悪寒はFNを疑い夜間休日でも受診	△ ここに注意 Grade2以上はトレーシングレポートで共有